

五年存活率到底是什麼意思？怎麼解讀才不被嚇到

Five-year survival rate: what it means and how to read it

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/11 · 最後更新：2026/05/11 · 審稿：林協霆 (2026/05/11) · 主題：癌症 5 年存活率解讀 (Interpreting 5-year cancer survival)

摘要 · ABSTRACT

「五年存活率 30%」≠「我只剩五年」。本文用病人語言拆開 5 年存活率的算法：相對 vs. 絕對、淨存活、有條件存活、SEER 資料庫、領先時間偏差，並說明為什麼 5 年數字是 5 年前診斷的人的歷史紀錄、不代表今天的你。

「5 年存活率 30%」不等於「我只剩 5 年」。這是「同類診斷的人中、5 年後仍存活的比例」——群體統計，不是個人判決。更重要的是：今天的 5 年存活率是「5 年前診斷的人」的歷史紀錄；這 5 年內上市的新藥 (osimertinib、T-DXd、CAR-T、KEYNOTE 免疫療法、CDK4/6 抑制劑) 多半還沒反映在數字裡。本文拆開相對 vs. 絕對存活、有條件存活、領先時間偏差、SEER 與台灣癌症登記的差異，並提供「拿到數字後該怎麼問」的問題清單。

閱讀對象

本文設定讀者為剛拿到診斷、被數字嚇到的病友與家屬，以及第一線解釋預後的醫療同仁。實際個別預後請以主治醫師判斷為準。



5 年存活率怎麼算？

名詞	定義	用途
絕對存活率 (OS)	診斷後 N 年仍存活的比例 (不分死因)	全因死亡率反映
相對存活率 (RS)	$OS \div \text{同年齡/性別/種族普通人群預期存活率}$	反映癌症淨影響
疾病特定存活率 (cancer-specific survival, CSS)	因該癌症死亡的比例	排除其他死因
無病存活率 (DFS / RFS)	治療後未復發的比例	早期癌術後評估
無進展存活率 (PFS)	治療開始後未進展或死亡的比例	第四期試驗常用
客觀反應率 (ORR)	治療後腫瘤縮小達標的比例	試驗早期讀出

不同名詞代表的時間段不同

OS 計時從「診斷」或「治療開始」算到「死亡或最後追蹤」；**PFS** 計時從「治療開始」算到「進展或死亡」；**ORR** 是治療反應，不是時間。看試驗或新聞報導時，請先看清楚是哪一個數字。

SEER vs. 台灣癌登：兩個常用的資料庫

項目	SEER (美國)	台灣癌登 (國健署)
涵蓋人口	美國 ~48% 人口	全台癌症登記
公開時間延遲	約 4-5 年	約 4-5 年
存活率算法	多用相對存活率	觀察 / 相對 / 淨存活率皆有
分期使用	SEER summary stage (in situ / localized / regional / distant)	AJCC 分期 + SEER summary

台灣癌登每年公布「中華民國 XX 年癌症登記報告」，可下載各癌別、各期別的 5 年觀察 / 相對存活率。注意這份報告通常落後 4-5 年——例如 2026 年公布的可能是 2021 年診斷者的 5 年存活率。

數字背後的偏差

領先時間偏差 (lead-time bias)

篩檢提早發現診斷時間，「5 年計時起點」提前；即使死亡時間不變，5 年存活率「看起來」上升。真正評估篩檢效益要看「人口死亡率下降」，而不是「個人 5 年存活率上升」。

長度偏差 (length bias)

篩檢容易抓到生長緩慢的腫瘤，這些腫瘤的「自然預後」本來就好；快速進展的腫瘤可能在兩次篩檢之間就以症狀出現，被歸到「症狀發現」組。

階段遷移 (stage migration / Will Rogers effect)

新影像 (PET-CT、MRI) 能找到更小的轉移；過去算「第三期」的人，現在被重新分為「第四期」。每一期的存活率都會看起來上升，但整體人口死亡率沒變——只是把較差預後的人從第三期搬到第四期。

選擇偏差

臨床試驗的病人通常 ECOG 0–1、年輕、共病少；現實世界的病人多元，存活率通常較試驗低。

有條件存活率：更實用的概念

有條件存活率 (conditional survival)：已經活過 N 年，再活 M 年的機率。

癌別	診斷時 5 年 OS	活過 2 年後再 3 年 OS (粗估)
第四期肺腺癌 (EGFR 突變)	20–30%	60–70%
第四期 HER2+ 乳癌	30–40%	60–70%
第四期黑色素瘤	30–40%	60–70%
多發性骨髓瘤	50–60%	70–80%
第四期 SCLC	5–10%	30–40%

「活過早期高峰」之後，後續存活率多半會大幅提升——這是診斷當下的數字無法反映的。

為什麼「今天的 5 年存活率」可能還是低估你的預後

近 5 年腫瘤醫療的主要進展：

年份	重大突破	影響癌別
2020–2022	T-DXd 跨適應症 (HER2+/HER2-low 乳癌、HER2+ 胃癌、肺癌)	乳癌、胃癌、肺癌
2020–2025	osimertinib 一線 (FLAURA)、輔助 (ADAURA)	EGFR 肺癌
2021–2024	CAR-T 跨產品 (DLBCL、FL、MCL、myeloma)	血液腫瘤
2021–2024	KEYNOTE-177、KEYNOTE-590、KEYNOTE-859 等 immune+ 化療	大腸、食道、胃
2022–2025	dostarlimab、pembrolizumab 在 dMMR / MSI-H 子宮內膜、大腸	婦癌、大腸
2022–2025	EV+pembrolizumab 一線 urothelial	泌尿上皮癌
2024–2025	KRAS G12C 抑制劑、HER2 弱陽性適應症	多癌別

這些藥多在過去 5 年才上市，今天公布的 5 年存活率（多為 2018–2020 年診斷者）多半還沒反映這些藥的效果。實際你能用到的治療版本，幾乎一定比歷史數字更好。

拿到 5 年存活率數字後該問什麼

這數字是哪一年診斷者的？

SEER / 台灣癌登的數字通常落後 4–5 年。請問主治醫師「最新藥物對這個數字會怎麼修正？」

是相對還是絕對存活率？

相對存活率較能反映癌症本身的影響。

我這個亞型 (biomarker) 的存活率是多少？

例如 HER2+ vs. 三陰性乳癌，5 年 OS 差很多。請依生物標記細分。

我已經活過了 X 個月，有條件存活率是多少？

這比診斷當下的數字更貼近現實。

有沒有適合我的臨床試驗？

試驗藥可能改變未來 5 年的數字。

適用對象 / 不適用對象

本文適用

- 剛拿到診斷、被存活率數字嚇到的病友與家屬
- 想了解預後資料來源與限制的同業
- 第一線解釋預後的醫療同仁

本文不適用

- 取代主治醫師對個人預後的判斷
- 期待「精確個人化倒數」者——個人預後は隨時間動態變化的範圍，不是單一數字



參考文獻

1. National Cancer Institute. **SEER Cancer Statistics Review, 1975–2019**. SEER. seer.cancer.gov/csr
2. 衛生福利部國民健康署. **中華民國癌症登記報告**. 國民健康署癌症防治組.
<https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=119>
3. Mariotto AB, et al. **Cancer survival: an overview of measures, uses, and interpretation**. *J Natl Cancer Inst Monogr*. 2014;2014(49):145–186. doi:10.1093/jncimonographs/lgu024
4. Welch HG, et al. **Are increasing 5-year survival rates evidence of success against cancer?** *JAMA*. 2000;283(22):2975–2978. doi:10.1001/jama.283.22.2975
5. Janssen-Heijnen MLG, et al. **Prognosis for long-term survivors of cancer**. *Ann Oncol*. 2007;18(8):1408–1413. doi:10.1093/annonc/mdm127
6. Esserman LJ, et al. **Overdiagnosis and overtreatment in cancer: an opportunity for improvement**. *JAMA*. 2013;310(8):797–798. doi:10.1001/jama.2013.108415

引用整理協力：SEER、台灣癌登、Welch 2000 JAMA、Mariotto 2014 JNCI Monogr (2026/05/11)。
LINE 官方帳號 @927pjta 接受文章勘誤、衛教提問與學術討論，不提供個別診療建議。

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/5-year-survival-rate-explained>

CITATION 林協霆. 五年存活率到底是什麼意思？怎麼解讀才不被嚇到. 林協霆 · 臨床筆記. 2026/05/11.

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN/ASCO/ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。